

TRACTAMENT INICIAL SCA

- **Valoració integral** del/la pacient i història clínica completa.
- **Oxigenoteràpia:** Només si $SpO_2 < 90\%$.
- **Analgèsia:**
Opiacis: Poden alentir l'absorció intestinal dels fàrmacs antiagregants.
Precaució pels efectes secundaris. Individualitzeu en cas d'insuficiència cardíaca (utilitzeu dosi mínima efectiva).
Fentanil: 50-75 mcg i.v. Cada 5-10 min o bé,
Clorur mòrfic: 4-8 mg i.v. Amb dosis addicionals de 2 mg cada 5-15 min, màxim 15-20 mg.
- **Antianginosos:**
Nitroglicerina:
 - Sublingual: 0,4 mg s.l.
 - Intravenosa (adults) 10-60 µg/kg/h (dilueu-ne 10 mg en 50 ml de SG 5%. Inicieu amb 5 ml/h). Augmenteu la dosi cada 3-5 minuts fins aconseguir l'efecte desitjat o l'aparició d'efectes adversos. Dosi màxima 200 µg/minut (60 ml/h).
 - **NO administreu Nitroglicerina:**
 - Com a diagnòstic diferencial del dolor toràcic.
 - TAS < 90 mmHg, FC < 50 bpm, sospita d'IAM ventriclle dret o presa en les últimes 24h d'inhibidors de la fosfodiesterasa (disfunció erètil).
- **Antiagregació:**
AAS: 150-300 mg v.o. mastegada. Si ingesta impossible: 450 mg i.v. d'Acetilsalicilat de Lisina. **No l'administreu** si al·lèrgia o contraindicació establerta.
Administració de 2n antiagregant, segons estratègia de reperfusió (veieu algoritme).
- **Anticoagulació:**
Si angiopàstia primària, bolus d'heparina sòdica (HNF) i.v. (70 UI/kg). Si fibrinòlisi, veieu apartat específic.
No l'administreu davant dubtes diagnòstics⁽²⁾, hemorràgia activa o criteris d'alt risc hemorràgic⁽³⁾.
- **Control de glicèmia.**
- **Control dels vòmits.**

CLASSIFICACIÓ DE KILLIP/KIMBALL

Killip I:
auscultació normal.

Killip II:
estertors crepitants i/o 3r soroll.

Killip III:
Edema agut de pulmó.

Killip IV:
Xoc cardíogenic.

FIBRINÒLISI PREHOSPITALÀRIA

- **Oxigenoteràpia:** Només si $SpO_2 < 90\%$.
- **Antiagregació:**
AAS 150-300 mg v.o. +
Clopidogrel (< 75 anys: 300 mg v.o., > 75 anys: 75 mg v.o.).
NO administreu Prasugrel ni Ticagrelor si fibrinòlisi.
- **Anticoagulació:**
Enoxaparina i.v.: < 75 a sense insuficiència renal (creatinina < 2,5mg/ml o < 2 mg en dones): Bolus de 30 mg i.v. seguit als 15 min. d'1 mg/kg s.c. (primeres dosis no superar 100 mg).
> 75 a i/o insuficiència renal: No bolus inicial, inicieu amb 0,75 mg/kg s.c. (màx. 75 mg).
- **Fibrinolític:**
Tenecteplasa (TNK), en < 10 minuts de l'ECG diagnòstic, en bolus ràpid (< 10 segons), ajustat al pes (**en > 75 a 50% de la dosi**):

Pes (kg)	Tenecteplasa (mg)	Volum solució	Volum solució > 75a (50%)
< 60	30 (amp. de 10 ml)	6 ml	3 ml
> 60 - 70	35 (amp. de 10 ml)	7 ml	3,5 ml
> 70 - 80	40 (amp. de 10 ml)	8 ml	4 ml
> 80 - 90	45 (amp. de 10 ml)	9 ml	4,5 ml
> 90	50 (amp. de 10 ml)	10 ml	5 ml

CONTRAINDICACIONS ABSOLUTES DE LA FIBRINÒLISI

- Antecedent d'hemorràgia cerebral prèvia o AVC de causa desconeguda.
- AVC isquèmic en els últims 6 mesos.
- Neoplàsia o traumatisme en el SNC, malformació vascular intracraneal coneguda.
- Traumatisme / cirurgia / dany en el darrer mes.
- Sospita de dissecció aòrtica.
- Trauma/cirurgia important o trauma craneofacial < 3 mesos.
- Sagnat actiu conegut (excepte menstruació).
- Sagnat gastrointestinal en l'últim mes.
- Puncions no compressibles recents (biòpsia hepàtica, punció lumbar, etc.).

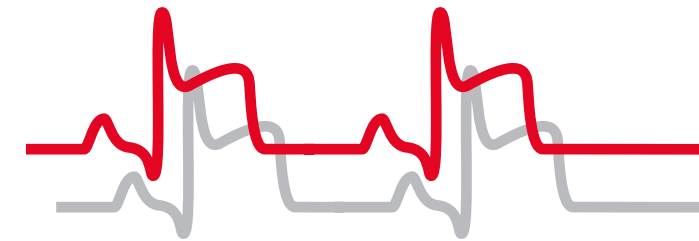
CONTRAINDICACIONS RELATIVES DE LA FIBRINÒLISI

- Accident isquèmic transitori en els darrers 6 mesos.
- Tractament anticoagulant oral.
- Gestació o primera setmana posterior al part.
- HTA refractària (TAS > 180 mmHg i/o diastòlica > 110 mmHg).
- Malaltia hepàtica avançada.
- Endocarditis infecciosa.
- Úlcera pèptica activa.
- Maniobles de ressuscitació perllongades o reanimació traumàtica.

U100.U00.4.D2.0036

V 03. abril 2023

CODI IAM



Atenció
d'emergència a la
malaltia
cardiovascular



Autoria: Grup de Treball en Síndrome Coronària Aguda (SCA) del SEM. Disseny: M. Fàbrega.

Salut/ emergències mèdiques

 **Generalitat
de Catalunya**

Amb l'aval del:

 **Pla director de les Malalties
Cardiovasculars**

CRITERIS ELECTROCARDIOGRÀFICS d'activació del CODI IAM

■ Nova elevació del segment ST al punt J en 2 derivacions contigües:

- $\geq 1\text{mm}$ (0,1mV) a totes les derivacions, excepte V2-V3.
- Derivacions de V2-V3:
 - $\geq 2\text{mm}$ en homes > 40 anys.
 - $\geq 2,5\text{mm}$ en homes < 40 anys.
 - $\geq 1,5\text{mm}$ en dones, independentment de l'edat.

■ Depressió del segment ST $\geq 1\text{mm}$ en 8 o més derivacions de superfície + elevació del segment ST a aVR

- Sospita d'oclusió del tronc comú o malaltia multivas.

■ Elevació persistent del segment ST $\geq 0.5\text{ mm}$ en les derivacions V7-V9 amb descens especular de les derivacions V1-V3

- Sospita d'infart de miocardi posterior.

■ Elevació del segment ST en derivacions dretes

- Sospita d'infart de miocardi ventriclle dret.

■ Bloqueig de Branca Esquerra de Feix de His (BBEFH) de nova aparició

- Valoreu criteris d'Sgarbossa-Smith (més avall).

■ Bloqueig de Branca Dreta de Feix de His (BBDFH) de nova aparició

■ Patró de Winter

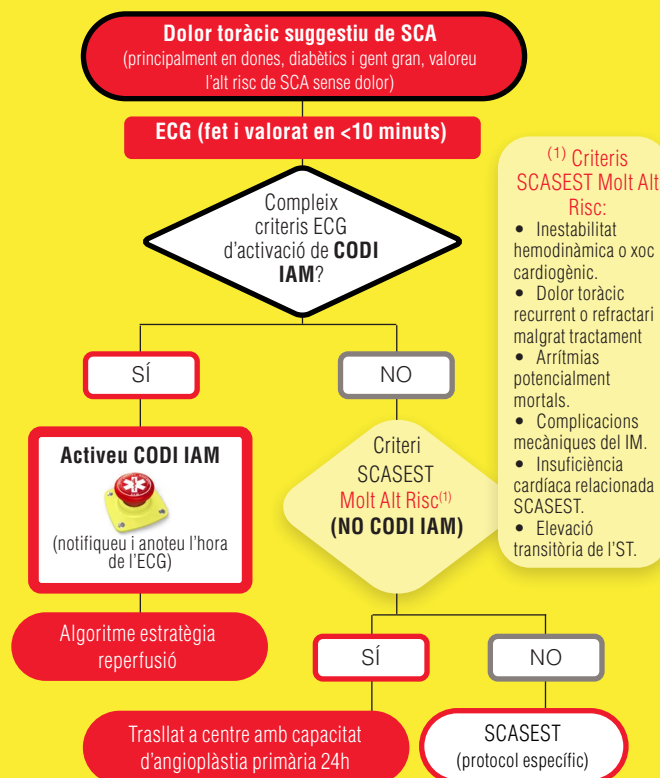
■ Ritme de marcapassos (BBEFH)

- Durant l'estimulació del ventriclle dret, l'ECG també mostra BBEFH i els criteris Sgarbossa-Smith també són aplicables però menys específics.

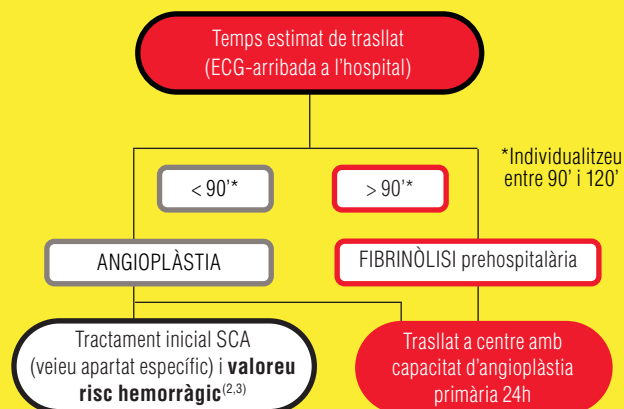
CRITERIS SGARBOSSA-SMITH:

- Elevació concordant de l'ST amb el QRS $> 1\text{ mm}$ a qualsevol derivació (5 punts).
 - Descens concordant del l'ST amb el QRS $> 1\text{ mm}$ a V1, V2 o V3 (3 punts).
 - Elevació o descens discordant de l'ST amb el QRS, $> 25\%$ (2 punts).
- Puntuacions iguals o superiors a 3 tenen una alta sensibilitat per diagnòstic IAM.

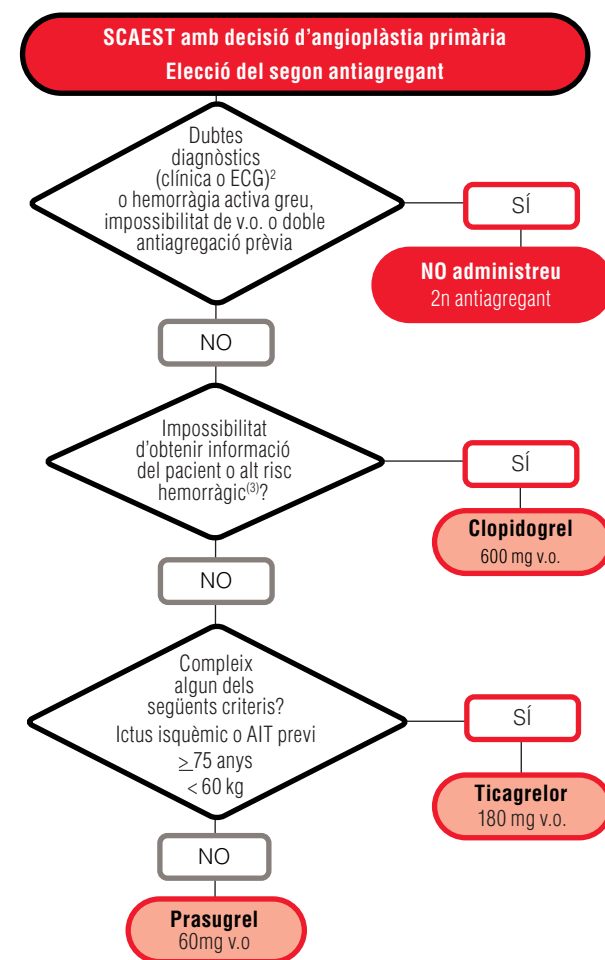
ALGORITME DIAGNÒSTIC



ALGORITME ESTRATÈGIA REPERFUSIÓ



ALGORITME 2n ANTIAGREGANT



(2) NO ADMINISTREU antiagregants ni anticoagulants davant ECG dubtós, aturada cardíaca sense ECG clar, alta sospita d'elevació de ST per trastorn neurològic i Síndrome aòrtica aguda.

(3) Criteris d'alt risc hemorràgic

- Anticoagulació oral.
- Hemorràgia intracranial prèvia.
 - Hemorràgia greu (requerint hospitalització o transfusió) als últims 6 mesos.
 - Neoplàsia activa.
 - Cirurgia major o traumatisme greu a l'últim mes.
 - Insuficiència hepàtica severa (Child Pugh C).
 - Patologia terminal o fragilitat manifesta.